Aprendizado de máquina para estratificação de risco de morte súbita cardíaca a partir do Holter de 24 horas

Defesa de dissertação de mestrado

Daniel Oliveira dos Santos

Orientador: Prof. Dr. João Paulo do Vale Madeiro

Coorientador: Prof. José Maria da Silva Monteiro Filho

10 de novembro de 2026

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (MDCC)
Universidade Federal do Ceará

Roteiro

1. Introdução
2. Trabalhos relacionados
3. Fundamentação teórica
4. Metodologia
5. Resultados
6. Conclusões

Morte súbita cardíaca: quando o coração para sem aviso

Na insuficiência cardíaca, a morte chega por duas vias: a **falência de bomba**, lenta e progressiva, e a **morte súbita cardíaca (MSC)**, abrupta.

O que é	Quanto pesa	Como se previne
evento abrupto, em geral por arritmia ventricular, em paciente muitas vezes estável	cerca de **metade** das mortes na insuficiência cardíaca (TOMASELLI; ZIPES, 2004)	cardiodesfibrilador implantável, indicado pela fração de ejeção (FEVE) (BARDY et al., 2005)

O que esses fatos têm em comum?

A MSC nasce de uma **falha elétrica** do coração — e é justamente a atividade elétrica que o ECG registra. O Holter de 24 horas, que a acompanha por um dia inteiro, já guardaria sinais desse risco?

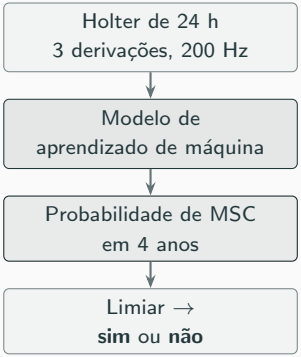
O que queremos prever?

Classificar quem terá MSC em 4 anos (sim ou não)

- O modelo estima uma **probabilidade** de MSC para cada paciente.
- A **AUC** avalia essa probabilidade: os casos recebem risco maior que os controles?
- Um **limiar** transforma a probabilidade em sim ou não, para calcular sensibilidade e especificidade.

A partir do Holter de 24 horas

- Exame não invasivo, barato e amplamente disponível.
- Registra ectopias, pausas e a variação da frequência entre sono e vigília.



Por que a fração de ejeção não basta

Hoje, a decisão de implantar o cardiodesfibrilador depende basicamente de **um único número**: a FEVE abaixo de um limiar (ZEPPENFELD et al., 2022).

Quem recebe o dispositivo

Muitos pacientes nunca chegam a utilizá-lo: o critério indica pessoas que não teriam a arritmia.

Quem fica de fora

Parte das mortes súbitas ocorre com FEVE **acima** do limiar: o critério não alcança esses pacientes.

Por que isso importa

Há espaço para ferramentas que **estratifiquem melhor** o risco de MSC — e o ECG, que mede diretamente a atividade elétrica, é um candidato natural.

Como a literatura tem abordado o problema

Os trabalhos se organizam em duas frentes, raramente comparadas entre si:

Marcadores definidos por especialistas

- VFC, ectopia, turbulência, repolarização.
- Combinados com variáveis clínicas em modelos estatísticos.
- Na base MUSIC: (RAMÍREZ et al., 2017; SWEE et al., 2026).

Redes profundas sobre o sinal

- Sucesso no **diagnóstico** de arritmias (HANNUN et al., 2019; RIBEIRO et al., 2020).
- Na **predição** de eventos, os melhores resultados usaram redes pré-treinadas em grandes bases (KIM et al., 2025).

Prever não é diagnosticar

O evento ocorre meses ou anos depois do exame, e as coortes têm poucas centenas de pacientes.

Objetivo e contribuição deste trabalho

Objetivo geral

Investigar métodos de aprendizado de máquina e de pré-processamento do ECG para prever a MSC em pacientes com insuficiência cardíaca crônica, a partir do Holter de 24 horas, em quatro anos de acompanhamento.

Três lacunas motivam o trabalho:

1. **falta de comparação direta**: cada estudo avaliou uma única abordagem, em coortes e protocolos diferentes;
2. **avaliação otimista**: métricas por trecho do sinal e seleção de variáveis com o desfecho de toda a coorte (KAPOOR; NARAYANAN, 2023);
3. **fibrilação atrial na coorte**, que pode inflar a discriminação.

Contribuição: três cenários nos mesmos 517 pacientes

I. redes profundas sobre o sinal bruto; **II.** marcadores extraídos do ECG com aprendizado de máquina clássico; **III.** variáveis clínicas, isoladas e combinadas ao ECG — com avaliação por paciente e em ritmo sinusal.

Roteiro

1. Introdução
2. Trabalhos relacionados
3. Fundamentação teórica
4. Metodologia
5. Resultados
6. Conclusões

Na coorte MUSIC: marcadores do ECG e variáveis clínicas

Ramírez et al. (2017)

- 597 pacientes em ritmo sinusal, 49 mortes súbitas.
- Marcadores da repolarização e turbulência + clínicos, em modelo de Cox.
- AUC de 0,73 na FEVE reduzida, **sem validação separada**.

Swee et al. (2026)

- 746 pacientes, **sem restrição de ritmo**, derivação Y.
- Marcadores de segmentos de 30 s; sequência processada por rede convolucional temporal (múltiplas instâncias).
- AUC de 0,682 $\pm$ 0,030 apenas com o ECG (média entre partições).

Redes profundas no Holter, e onde este trabalho se encaixa

Kim et al. (2025)

- 1 108 pacientes (infarto ou insuficiência cardíaca), 70 eventos.
- Codificador pré-treinado e congelado; só um classificador pequeno é ajustado.
- AUC de 0,74 na coorte completa, mas **0,60** no subgrupo com insuficiência cardíaca.

Este trabalho

- Três abordagens no **mesmo protocolo** e nos mesmos pacientes.
- Controle do otimismo: avaliação por paciente, seleção dentro da partição, intervalos de confiança.
- Restrição ao **ritmo sinusal**.

Roteiro

1. Introdução
2. Trabalhos relacionados
3. Fundamentação teórica
4. Metodologia
5. Resultados
6. Conclusões

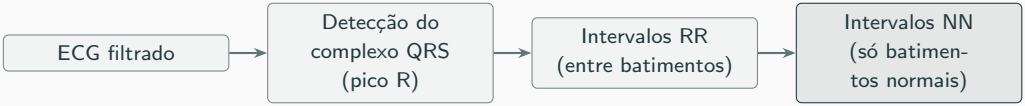
Antes de analisar: limpar o sinal do ECG

- **Interferências**: oscilação de linha de base ($<$ 0,5 Hz), ruído muscular, rede elétrica (50 Hz).
- **Filtro passa-faixa** Butterworth 0,5–40 Hz, aplicado nos dois sentidos (fase nula).
- **Normalização** da amplitude por derivação.
- **Janelas**: o registro de 24 h é dividido em trechos; janelas de um mesmo paciente **não são independentes**.



10 s de Holter, derivações X, Y e Z, após o filtro.

Do sinal aos marcadores: detecção do QRS e intervalos RR



- **Variabilidade da frequência cardíaca**: como os intervalos NN oscilam no tempo (SDNN, RMSSD, pNN50) e na frequência (VLF, LF, HF).
- **Morfologia**: duração do QRS, intervalos QT e QTc, ondas P e T.
- **Ectopia**: batimentos precoces, extrassístoles, dupletes e pausas.
- Quanto mais longo o segmento, mais estáveis as medidas; os índices de frequência exigem segmentos longos.

A lista completa dos marcadores usados está na Metodologia (Cenário II).

Redes convolucionais: aprender padrões direto do sinal

- **Convolução 1D**: filtros que deslizam no tempo e detectam padrões locais (núcleo de 75 ms $\approx$ um QRS).
- Cada bloco: convolução $\rightarrow$ normalização em lote $\rightarrow$ ReLU $\rightarrow$ agrupamento máximo $\rightarrow$ descarte.
- **Agrupamento global** (média e máximo) e classificador.
- Perda: entropia cruzada ponderada, $w_{+} = N_0/N_1 \approx 8{,}4$.

A arquitetura completa, com as dimensões de cada bloco, está na Metodologia (Cenário I).

Redes residuais: como treinar redes mais profundas

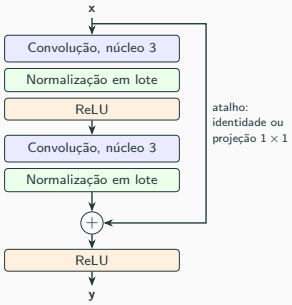
- Problema: redes muito profundas ficam difíceis de treinar.
- **Aprendizado residual** (HE et al., 2016): o bloco aprende só a diferença $\mathcal{F}(\mathbf{x})$ e soma a entrada:

$$\mathbf{y} = \mathrm{ReLU}\big(\mathcal{F}(\mathbf{x}) + \mathbf{x}\big)$$

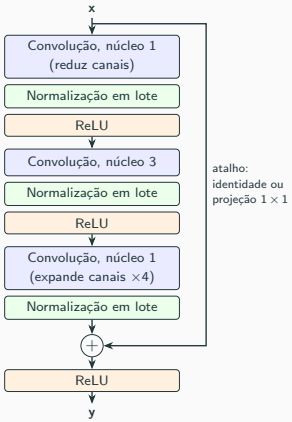
- Atalho: identidade, ou projeção 1×1 quando muda a dimensão.
- Dois tipos de bloco neste trabalho: **básico** (duas convoluções) e de **gargalo** (três convoluções, mais barato em redes profundas).
- A cada estágio da rede: comprimento $\div 2$ e canais $\times 2$.

Redes residuais: blocos básico e de gargalo

(a) Bloco básico ($E = 1$)



(b) Bloco de gargalo ($E = 4$)



Atenção: relacionar instantes distantes do registro

- Convoluções relacionam apenas instantes **vizinhos**; ao final da ResNet-18, o campo receptivo é de cerca de 2,2 s.
- A **autoatenção** (VASWANI et al., 2017) relaciona cada posição com todas as outras em uma única operação:

$$\text{Atenção}(Q, K, V) = \mathrm{softmax}\left(\frac{QK^{\top}}{\sqrt{d}}\right) V$$

- Neste trabalho: ResNet-18 reduzida como extrator, seguida de **uma camada codificadora** *Transformer* (4 cabeças).
- Custo cresce com o quadrado do comprimento da sequência.

Modelos clássicos: poucas variáveis, poucos eventos

Regressão logística regularizada

L2: reduz os coeficientes sem zerá-los.
L1: zera coeficientes e seleciona variáveis.

Análise de componentes principais

Substitui marcadores correlacionados por poucas combinações não correlacionadas, sem usar o desfecho.

Floresta aleatória (BREIMAN, 2001)

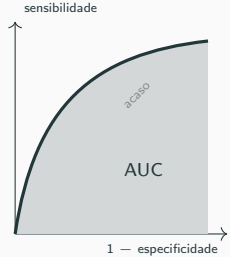
Conjunto de árvores de decisão; captura relações não lineares e interações entre marcadores.

Por que modelos simples?

55 eventos: a regra de dez eventos por variável limita o modelo a poucas variáveis.

Como medir se o modelo separa casos de controles?

- **AUC**: probabilidade de o modelo dar risco maior a um caso do que a um controle. 0,5 = acaso; 1 = perfeito.
- **AUPRC**: área sob a curva precisão–revocação; acaso = prevalência (0,106) (DAVIS; GOADRICH, 2006).
- **Agregação por paciente**: média das probabilidades das janelas.
- **Intervalo de confiança** por *bootstrap* de pacientes.



Roteiro

1. Introdução

2. Trabalhos relacionados

3. Fundamentação teórica

4. Metodologia

5. Resultados

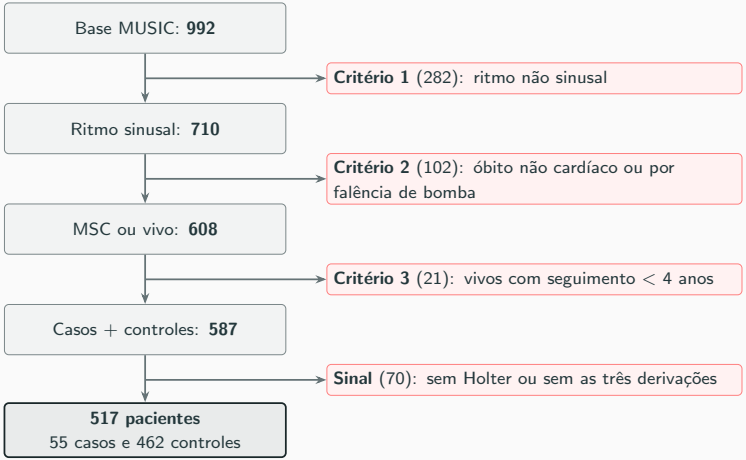
6. Conclusões

População de estudo
Pré-processamento do sinal
Cenário I: redes profundas
Cenário II: marcadores do ECG
Cenário III: variáveis clínicas
Avaliação dos modelos

A base MUSIC: 992 pacientes acompanhados por quatro anos

- Pública no PhysioNet (MARTIN-YEBRA; MARTÍNEZ; LAGUNA, 2025; MARTÍN-YEBRA et al., 2024).
- **992 pacientes** com insuficiência cardíaca crônica (NYHA II e III), recrutados em 2003–2004 em oito hospitais da Espanha.
- Acompanhamento mediano de 44 meses.
- **Holter de 24 h** em 936 pacientes: derivações X, Y e Z, 200 Hz.
- Causas de óbito **adjudicadas**: separam a MSC da falência de bomba.
- Variáveis clínicas e exames na entrada do estudo.

Quem entra no estudo: de 992 a 517 pacientes



Classificação binária por paciente: MSC (casos) contra sobreviventes em 4 anos (controles). Prevalência de 10,6 %.

Quem entra no estudo: o fluxo em números

Etapa	N
Pacientes na base MUSIC	992
Excluídos: ritmo não sinusal	282
Em ritmo sinusal	710
Excluídos por desfecho ambíguo	123
Morte não cardíaca	35
Falência de bomba	67
Vivos com seguimento $<$ 4 anos	21
Casos + controles	587
Sem registro de Holter	47
Registro sem derivação Z	23
Analisados	**517**
Casos (MSC)	55
Controles	462

Por que tantos critérios?

- **Rótulo confiável**: só MSC contra sobreviventes em 4 anos.
- **Sinal homogêneo**: ritmo sinusal e três derivações.

O custo

Os resultados valem para insuficiência cardíaca em **ritmo sinusal**; prevalência de **10,6 %**.

O que se sabe do paciente além do Holter

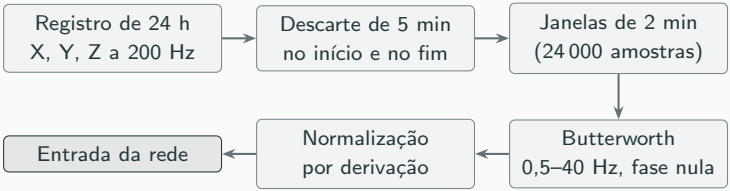
Seis variáveis clínicas

- Idade (anos)
- Classe funcional NYHA (ordinal)
- Gênero
- Ondas Q de necrose
- Taquicardia ventricular não sustentada
- Taquiarritmia supraventricular paroxística

Exames do estudo

- **Ecocardiograma**: FEVE, diâmetros, contratilidade do VD.
- **Laudo do ECG de repouso**: PR, QT, QRS.
- **Medidas do Holter** tabuladas: extrassístoles, SDNN, RMSSD.
- **Pro-BNP**.

Do registro de 24 horas à entrada da rede



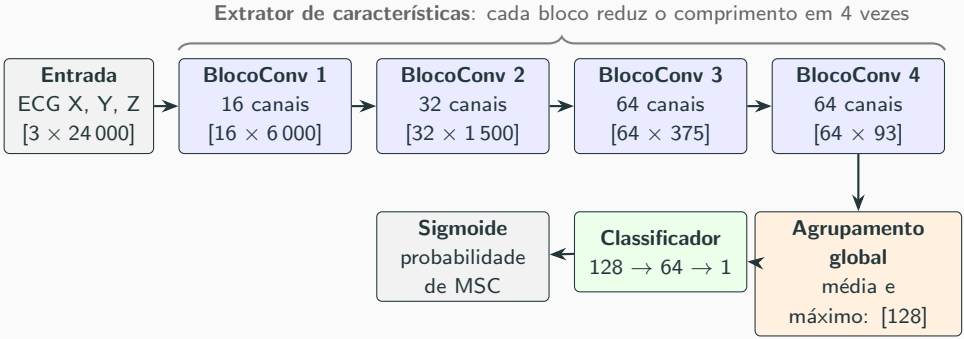
- Treinamento: 250 a 350 janelas por paciente, com posição sorteada.
- Avaliação: 100 a 200 janelas em grade regular (reprodutível).
- A escala da normalização é calculada só com o treinamento.

Cenário I: redes de 14 mil a 16 milhões de parâmetros

Família	Variante	Parâmetros	Janela
Convolucional	mínima (3 blocos)	14 425	2 min e 10 s
	simples (4 blocos)	109 361	2 min e 10 s
	média (4 blocos)	418 145	2 min e 10 s
Residual	ResNet-18 mínima	78 169	5,12 s
	ResNet-18 reduzida	1 029 985	2 min
	ResNet-18	3 976 385	2 min e 5,12 s
	ResNet-34	7 350 721	2 min
	ResNet-50	16 479 937	2 min
Atenção	ResNet-18 + *Transformer*	1 491 553	2 min

Capacidade variando em mais de mil vezes: se o desempenho não acompanhar, a limitação está nos dados, e não na rede.

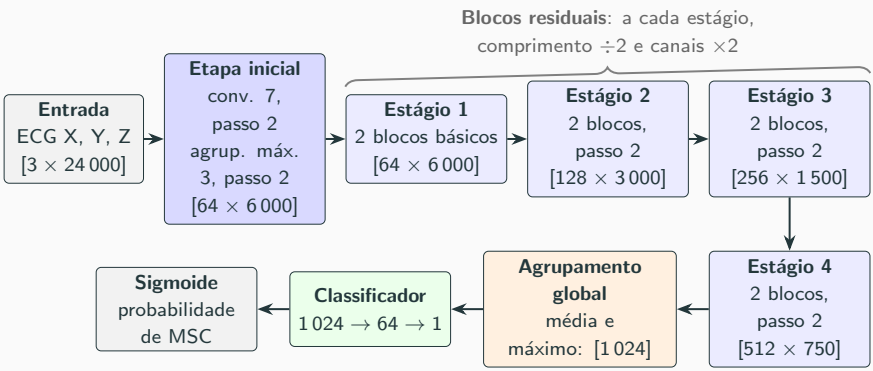
Cenário I: arquitetura da rede convolucional



Cada BlocoConv: convolução 1D (núcleo de 15 amostras, 75 ms) → normalização em lote → ReLU → agrupamento máximo (fator 4) → descarte (0,1).
Classificador: descarte (0,5) → linear (128 → 64) → normalização em lote → ReLU → descarte (0,5) → linear (64 → 1).

Variante simples, janela de 2 minutos (24 000 amostras a 200 Hz). O agrupamento global concatena a média e o máximo de cada canal; só depois dele atua o classificador.

Cenário I: arquitetura da ResNet-18

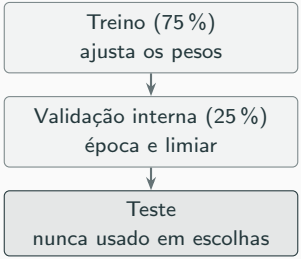


Cada estágio: dois blocos básicos (convolução 3 → normalização → ReLU → convolução 3 → normalização, somados ao atalho e seguidos de ReLU); no primeiro bloco dos estágios 2 a 4, passo 2 e atalho com projeção.
Classificador: descarte (0,5) → linear (1 024 → 64) → normalização em lote → ReLU → descarte (0,5) → linear (64 → 1).

ResNet-18 completa ($P = 64$), janela de 2 minutos. As demais variam blocos por estágio, P ou tipo de bloco.

Cenário I: como as redes foram treinadas

- Otimizador **AdamW**, taxa 10^{-4} com decaimento cosseno (LOSHCHILOV; HUTTER, 2017).
- **Desbalanceamento**: perda ponderada, $w_+ \approx 8{,}4$.
- **Seleção da época**: média móvel da AUC de validação nas três últimas épocas.
- **Limiar**: índice de Youden na validação interna.
- **Busca de hiperparâmetros**: Optuna, 25 tentativas por família.



Cenário II: dois protocolos para extrair os marcadores

	Protocolo A	Protocolo B
Segmento	5 minutos	30 segundos
Espaçamento	um por hora	um a cada 2 minutos
Segmentos por paciente	cerca de 21	cerca de 636
Derivação	a de maior desvio-padrão	Y
Domínio da frequência	sim	não
Ectopia	proporção de RR irregulares	contagens completas
Variáveis por paciente	44	32 a 122

- Cada marcador é calculado em cada segmento e **resumido por paciente** (média e desvio-padrão, ou mediana e percentis).
- Modelos: logística L1 e L2, PCA (4) + logística, floresta aleatória.

O que extraímos do ECG (1/2): ritmo e variabilidade

Marcador	Definição	Unidade	Significado	5 min	30 s
Frequência cardíaca média	60 000 dividido pela média dos intervalos NN	bpm	Nível de ativação do ritmo	sim	sim
Intervalo RR médio	Média dos intervalos NN	ms	Inverso da frequência	sim	sim
SDNN	Desvio-padrão dos intervalos NN	ms	Variabilidade total do segmento	sim	sim
RMSSD	Raiz da média dos quadrados das diferenças sucessivas	ms	Variação batimento a batimento; tônus vagal	sim	sim
pNN50	Porcentagem de diferenças sucessivas maiores que 50 ms	%	Tônus vagal	sim	sim
SD1 e SD2	Dispersões do gráfico de Poincaré	ms	Variabilidade de curto e de longo prazo	sim	sim
SD1/SD2	Razão entre as duas dispersões	—	Forma da nuvem de Poincaré	sim	sim
VLF, LF, HF, LF/HF	Potência espectral por faixa de frequência	u.a.	Modulação autonômica por mecanismo	sim	não
Entropia amostral	Regularidade da sequência de intervalos	—	Complexidade do ritmo	sim	não

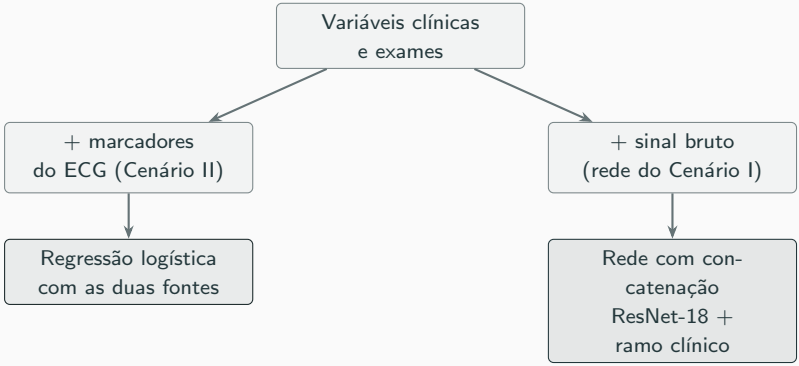
NN: intervalos entre batimentos normais. 5 min: protocolo A; 30 s: protocolo B. Medidas espectrais e entropia exigem segmentos longos, por isso não foram calculadas em 30 s. u.a.: unidades arbitrárias (espectro normalizado pelo NeuroKit2 (MAKOWSKI et al., 2021)).

O que extraímos do ECG (2/2): ectopia, pausas e morfologia

Marcador	Definição	Unidade	Significado	5 min	30 s
Ectopia e pausas (pelo ritmo, sem distinguir a origem)					
Batimentos precoces	RR menor que 80 % da mediana local	contagem	Batimentos fora do ritmo sinusal	não	sim
Extrassístoles	Precoce seguido de RR $>$ 115 % da mediana	contagem	Ectópico com pausa compensatória	não	sim
Dupletes	Dois intervalos precoces consecutivos	contagem	Ectopia repetitiva	não	sim
Carga de ectopia	Porcentagem de intervalos precoces	%	Frequência global de ectopia	não	sim
Intervalos irregulares	Porcentagem de intervalos que não são NN	%	Irregularidade do ritmo	sim*	sim
Maior pausa	Maior intervalo RR plausível	ms	Pausas e bradiarritmias	não	sim
Pausas acima de 2 s	Intervalos RR maiores que 2 000 ms	contagem	Pausas prolongadas	não	sim
Morfologia (mediana dos batimentos delineados)					
Duração do QRS	Do início ao fim do complexo QRS	ms	Condução ventricular	sim	sim
Intervalo QT	Do início do QRS ao fim da onda T	ms	Despolarização e repolarização	sim	sim
QTc	QT corrigido pela frequência (Bazett)	ms	Repolarização prolongada	sim	sim
Ondas P e T	Fração dos batimentos com cada onda	—	Qualidade da delineação	não	sim
Amplitude	Percentil 99 do sinal, por derivação	mV	Massa ventricular e geometria	sim	sim

*No protocolo A, proporção de intervalos afastados mais de 20 % da mediana. O protocolo A priorizou a variabilidade; o B, a ectopia.

Cenário III: as variáveis clínicas sozinhas e somadas ao ECG



- Referência: logística L2 sobre as seis variáveis clínicas.
- Rede com concatenação: treino conjunto, taxa reduzida no extrator ou extrator congelado.

Como avaliamos: cada paciente testado uma única vez

- Validação cruzada **estratificada em 5 partições**, dividida por paciente.
- Cada paciente cai no teste **uma única vez**.
- **AUC geral**: uma AUC sobre as predições dos 517 pacientes (medida principal).
- **AUC por partição**: média $\pm$ desvio-padrão das cinco AUC de teste.
- Comparações pareadas por *bootstrap*.

Rodada	Teste	Treino
1	104 (11)	413 (44)
2	104 (11)	413 (44)
3	103 (11)	414 (44)
4	103 (11)	414 (44)
5	103 (11)	414 (44)
Total	517 (55)	—

Pacientes (casos).

Roteiro

1. Introdução

2. Trabalhos relacionados

3. Fundamentação teórica

4. Metodologia

5. Resultados

6. Conclusões

Cenário I: redes profundas
Cenário II: marcadores do ECG
Cenário III: variáveis clínicas
Comparação entre os cenários

Cenário I: redes convolucionais não superaram o acaso

Rede	Janela	Parâmetros	AUC por partição	AUC geral [IC 95 %]
Mínima	2 min	14 425	0,543 ± 0,059	0,523 [0,440–0,612]
Simples	2 min	109 361	0,500 ± 0,067	0,486 [0,402–0,578]
Média	2 min	418 145	0,494 ± 0,119	0,485 [0,400–0,574]
Mínima	**10 s**	14 425	0,589 ± 0,090	**0,554** [0,467–0,634]
Simples	10 s	109 361	0,509 ± 0,051	0,491 [0,411–0,578]
Média	10 s	418 145	0,495 ± 0,118	0,485 [0,406–0,569]

Em resumo

Nenhuma configuração se distinguiu do acaso; a rede menor obteve os maiores valores.

Cenário I: redes maiores não ajudaram

Rede	Janela	Parâmetros	AUC por partição	AUC geral [IC 95 %]
ResNet-18 mínima	5,12 s	78 169	0,569 ± 0,067	**0,562** [0,475–0,642]
ResNet-18 reduzida	2 min	1 029 985	0,516 ± 0,102	0,504 [0,420–0,588]
ResNet-18	2 min	3 976 385	0,528 ± 0,088	0,508 [0,431–0,588]
ResNet-34	2 min	7 350 721	0,540 ± 0,039	0,514 [0,429–0,601]
ResNet-50	2 min	16 479 937	0,569 ± 0,098	0,536 [0,448–0,618]

Em resumo

Nem a largura nem a profundidade melhoraram o desempenho.

Cenário I: nem atenção nem busca automática mudaram o quadro

Rede	Janela	Parâmetros	AUC por partição	AUC geral [IC 95 %]
ResNet-18 + atenção	2 min	1 491 553	—	0,493
CNN (Optuna)	1 min	473 417	0,574 ± 0,112	0,556 [0,464–0,647]
ResNet (Optuna)	1 min	1 818 049	0,510 ± 0,079	0,496 [0,411–0,584]

- Relacionar instantes distantes do registro (atenção) não ajudou.
- A busca bayesiana não superou as configurações manuais: a CNN encontrada obteve o mesmo valor da CNN mínima (0,554).

Cenário I: o problema está no sinal, não no procedimento

Variabilidade entre execuções

ResNet-18 mínima treinada duas vezes, nas mesmas partições:

- 0,562 → **0,480**

A diferença (0,08) é maior que a diferença entre a melhor e a pior arquitetura.

Sem restrição ao ritmo sinusal

ResNet-18 em 703 pacientes e 85 casos:

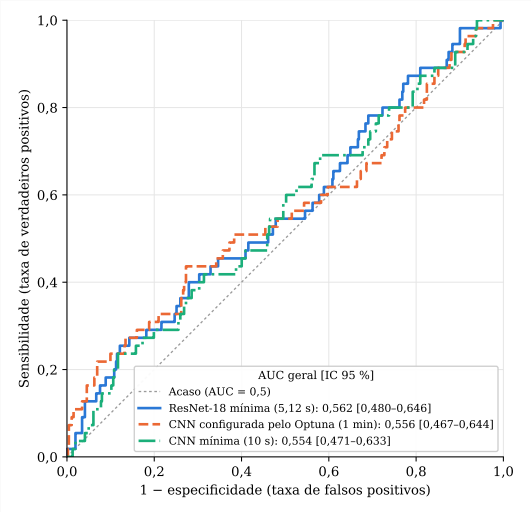
- AUC de **0,575** [0,511–0,642], único intervalo acima de 0,5.

A rede aprende quando há um padrão reconhecível: a fibrilação atrial.

Em resumo

O procedimento funciona; o sinal em ritmo sinusal é que não traz um padrão de MSC reconhecível pelas redes.

Cenário I: curvas próximas da diagonal do acaso



- 15 configurações: AUC geral entre **0,48 e 0,56**.
- Sem relação com a capacidade, a janela ou a atenção.
- Curvas ROC próximas da diagonal do acaso.
- VPP entre 0,09 e 0,14, próximo da prevalência (0,106).

Cenário I: todas as métricas das redes, lado a lado

Rede	Entrada	Janela	AUC	AUPRC	Sens.	Espec.	VPP	VPN	F1	Acur.
CNN mínima	ECG	2 min	0,523	0,139	0,582	0,448	0,111	0,900	0,187	0,462
CNN simples	ECG	2 min	0,486	0,121	0,364	0,645	0,109	0,895	0,167	0,615
CNN média	ECG	2 min	0,485	0,126	0,309	0,688	0,106	0,893	0,157	0,648
CNN mínima	ECG	10 s	0,554	0,132	0,691	0,346	0,112	0,904	0,192	0,383
CNN simples	ECG	10 s	0,491	0,119	0,400	0,530	0,092	0,881	0,150	0,516
CNN média	ECG	10 s	0,485	0,110	0,455	0,485	0,095	0,882	0,157	0,482
ResNet-18 mínima	ECG	5,12 s	0,562	0,160	0,455	0,654	0,135	0,910	0,208	0,632
ResNet-18 reduzida	ECG	2 min	0,504	0,117	0,582	0,437	0,110	0,898	0,184	0,453
ResNet-18 completa	ECG	2 min	0,508	0,121	0,455	0,461	0,091	0,877	0,152	0,460
ResNet-18 completa	ECG	5,12 s	0,492	0,129	0,582	0,442	0,110	0,899	0,186	0,456
ResNet-34	ECG	2 min	0,514	0,122	0,509	0,517	0,112	0,898	0,183	0,516
ResNet-50	ECG	2 min	0,536	0,137	0,455	0,511	0,100	0,887	0,163	0,505
ResNet-18 + Transformer	ECG	2 min	0,493	0,134	0,291	**0,703**	0,105	0,893	0,154	**0,660**
CNN (Optuna)	ECG	1 min	0,556	**0,189**	0,509	0,552	0,119	0,904	0,193	0,547
ResNet (Optuna)	ECG	1 min	0,496	0,122	0,455	0,565	0,111	0,897	0,178	0,553
ResNet-18, conjunto	ECG + clínicos	2 min	0,516	0,141	0,418	0,548	0,099	0,888	0,160	0,534
ResNet-18, taxa reduzida	ECG + clínicos	2 min	**0,579**	0,180	0,455	0,673	**0,142**	0,912	0,216	0,650
ResNet-18, congelada	ECG + clínicos	2 min	0,577	0,146	**0,727**	0,424	0,131	**0,929**	**0,222**	0,456
ResNet-18, conjunto	ECG + clínicos	10 s	0,491	0,113	0,400	0,569	0,100	0,889	0,159	0,551

melhor valor da coluna pior valor da coluna Valor de um classificador ao acaso: AUPRC e VPP = 0,106; VPN = 0,894

Cenário II: segmentos de 5 minutos superam as redes

Modelo	Var.	AUC geral [IC 95 %]	AUC por partição	AUPRC	Sens.	Espec.
Clínicas (referência)	6	0,661 [0,577–0,741]	0,673 ± 0,114	0,233	0,564	0,699
Marcadores, logística L2	44	0,589 [0,507–0,671]	0,595 ± 0,066	0,180	0,418	0,714
Marcadores, logística L1	44	0,585 [0,503–0,666]	0,588 ± 0,044	0,163	0,400	0,706
Marcadores, PCA (4) + logística	44	**0,624** [0,535–0,708]	0,623 ± 0,052	0,232	0,345	0,868
Marcadores, floresta aleatória	44	0,621 [0,537–0,701]	0,627 ± 0,025	0,184	0,400	0,801
Clínicas + marcadores, L2	50	0,672 [0,597–0,745]	0,679 ± 0,099	0,201	0,582	0,662
Clínicas + marcadores, L1	50	**0,681** [0,604–0,756]	0,690 ± 0,065	0,191	0,527	0,771

- Três marcadores resistiram à correção de Benjamini-Hochberg: média e desvio-padrão da potência HF e **desvio-padrão da frequência cardíaca**.
- Escolher poucos marcadores olhando toda a coorte dá cerca de 0,05 a mais (otimismo); dentro da partição, 0,580.
- As duas últimas linhas já combinam clínicas e ECG (Cenário III), e ficam aqui para comparação.

Sensibilidade e especificidade no limiar de cada modelo. AUPRC do acaso: 0,106.

Cenário II: segmentos de 30 s e a armadilha da pseudorreplicação

Unidade de análise

Análise	Signif. (de 24)
Por segmento (328 807)	22
Por paciente (517)	2
Após correção	0

Contar segmentos como pacientes infla a significância (pseudorreplicação; Hurlbert (1984)).

Modelos

- Treinados **sobre cada segmento**: 0,53 a 0,56.
- Sobre os resumos por paciente (12 configurações): **0,619** [0,537–0,700] no melhor caso (PCA, conjunto 2).
- Padrão consistente: casos com **menor variação da frequência** ao longo do dia.

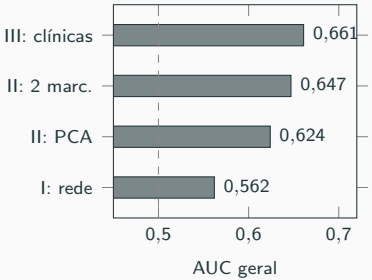
Cenário II: dois marcadores da frequência bastam

Escolhidos de antemão, pela literatura

- desvio-padrão da frequência cardíaca entre os segmentos;
- carga de ectopia;
- sem olhar o desfecho desta coorte.

Modelo e resultado

- logística L2, um modelo por derivação;
- AUC entre 0,635 e 0,660;
- **0,647** [0,563–0,726] na derivação de melhor qualidade.



Em resumo

Dois marcadores ligados à frequência cardíaca: 0,085 acima da melhor rede.

Cenário III: as variáveis clínicas superam todas as redes

Modelo (logística L2)	AUC geral [IC 95 %]
Seis variáveis clínicas	0,661 [0,577–0,741]
Ecocardiograma	0,714 [0,641–0,774]
Clínicas + ecocardiograma	0,720 [0,640–0,789]
Clínicas + todos os exames	**0,733** [0,656–0,804]
Todos os exames	0,738 [0,666–0,809]

- As variáveis clínicas superam todas as redes do Cenário I.
- O ecocardiograma foi o grupo de exames mais informativo (+0,058 sobre as clínicas).
- Pro-BNP: +0,047; laudo do ECG e medidas do Holter acrescentaram pouco.

Cenário III: somar o ECG às clínicas ajuda pouco

Clínicas + marcadores

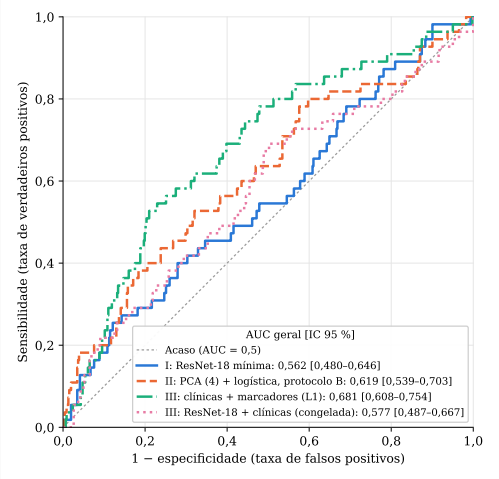
- Protocolo A: 0,661 → **0,681** (L1).
- Dois pré-especificados: 0,679 a 0,683.
- Ganho pequeno e consistente, **sem significância** estatística.

Clínicas + sinal bruto

Estratégia	AUC geral
Treino conjunto	0,516
Taxa reduzida	0,579
Extrator congelado	0,577

Pior que as clínicas sozinhas: o sinal treinado acrescenta variabilidade, não informação.

Os três cenários lado a lado



	Melhores resultados	AUC geral
I	ResNet-18 mínima	0,562
	CNN (Optuna)	0,556
	CNN mínima, 10 s	0,554
II	2 marcadores pré-especificados	0,647
	PCA (4), protocolo A	0,624
	PCA (4), protocolo B	0,619
III	Exames do estudo	0,738
	Clínicas + exames	0,733
	Clínicas + ecocardiograma	0,720

As curvas mostram os melhores modelos cujas predições foram salvas; a tabela traz os melhores valores de cada cenário.

Roteiro

1. Introdução
2. Trabalhos relacionados
3. Fundamentação teórica
4. Metodologia
5. Resultados
6. Conclusões

O que aprendemos

- **Cenário I**: redes profundas sobre o sinal bruto ficaram entre 0,48 e 0,56, sem se distinguir do acaso; em ritmo não sinusal, a mesma rede aprende.
- **Cenário II**: os marcadores extraídos do ECG superaram as redes; a informação está em **poucos marcadores** ligados à frequência cardíaca (0,647).
- **Cenário III**: clínicas sozinhas, 0,661; somadas aos marcadores, 0,681; com os exames, até 0,738.

Em resumo

O processamento do ECG com extração de características produziu preditores de MSC superiores ao aprendizado profundo sobre o sinal bruto.

Como esses resultados se comparam à literatura

- **Kim et al.**: 0,60 no subgrupo de insuficiência cardíaca, coerente com as redes deste trabalho.
- **Ramírez et al.**: 0,73 sem validação separada.
- **Swee et al.**: replicação nas condições deles (746 pacientes, derivação Y, segmentos contíguos).

Modelo (só ECG)	AUC por partição
44 marcadores, L1	0,605 $\pm$ 0,088
4 pré-especificados	**0,659** $\pm$ 0,078
Swee et al.	0,682 $\pm$ 0,030

Em resumo

Desempenho próximo ao de Swee et al., com modelos mais simples; a diferença está dentro do intervalo de confiança.

Limitações e próximos passos

Limitações

- Coorte única, sem validação externa.
- Um único Holter por paciente.
- Busca de hiperparâmetros sem validação cruzada aninhada.
- Desfecho binário em 4 anos, sem o tempo até o evento.

Trabalhos futuros

- Modelos sequenciais sobre os marcadores dos segmentos.
- Representações pré-treinadas e orientadas por atributos clínicos.
- Marcadores da repolarização (alternância da onda T).
- Análise de sobrevivência com riscos competitivos.
- Validação externa.

Obrigado!

Perguntas?

Daniel Oliveira dos Santos — MDCC/UFC

Apoio: CAPES — Código de Financiamento 001

Referências i

BARDY, G. H. et al. Amiodarone or an implantable cardioverter-defibrillator for congestive heart failure. *The New England Journal of Medicine*, v. 352, n. 3, p. 225–237, 2005.

BREIMAN, L. Random forests. *Machine Learning*, v. 45, n. 1, p. 5–32, 2001.

DAVIS, J.; GOADRICH, M. The relationship between precision-recall and ROC curves. In: *Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning*. [S.l.: s.n.], 2006. p. 233–240.

HANNUN, A. Y. et al. Cardiologist-level arrhythmia detection and classification in ambulatory electrocardiograms using a deep neural network. *Nature Medicine*, v. 25, n. 1, p. 65–69, 2019.

HE, K. et al. Deep residual learning for image recognition. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. [S.l.: s.n.], 2016. p. 770–778.

HURLBERT, S. H. Pseudoreplication and the design of ecological field experiments. *Ecological Monographs*, v. 54, n. 2, p. 187–211, 1984.

KAPOOR, S.; NARAYANAN, A. Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science. *Patterns*, v. 4, n. 9, p. 100804, 2023.

Referências ii

KIM, J. Y. et al. Deep learning-based risk assessment and prediction of cardiac outcomes using single-lead 24-hour Holter-ECG in patients with heart failure or myocardial infarction. *Journal of Clinical Medicine*, v. 14, n. 20, p. 7209, 2025.

LOSHCHILOV, I.; HUTTER, F. SGDR: Stochastic gradient descent with warm restarts. In: *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. [S.l.: s.n.], 2017.

MAKOWSKI, D. et al. NeuroKit2: A Python toolbox for neurophysiological signal processing. *Behavior Research Methods*, v. 53, n. 4, p. 1689–1696, 2021.

MARTÍN-YEBRA, A. et al. The MUSIC database: Sudden cardiac death in heart failure patients. In: *Computing in Cardiology*. [S.l.: s.n.], 2024. v. 51.

MARTIN-YEBRA, A.; MARTÍNEZ, J. P.; LAGUNA, P. *MUSIC (Sudden Cardiac Death in Chronic Heart Failure) (version 1.0.1)*. PhysioNet, 2025. RRID:SCR_007345. Disponível em: ⟨https://physionet.org/content/music-sudden-cardiac-death/1.0.1/⟩.

RAMÍREZ, J. et al. Sudden cardiac death and pump failure death prediction in chronic heart failure by combining ECG and clinical markers in an integrated risk model. *PLoS ONE*, v. 12, n. 10, p. e0186152, 2017.

RIBEIRO, A. H. et al. Automatic diagnosis of the 12-lead ECG using a deep neural network. *Nature Communications*, v. 11, p. 1760, 2020.

Referências iii

SWEE, S. et al. Multimodal integration of ambulatory ECG and clinical features for sudden cardiac death and pump failure death prediction. *medRxiv*, 2026. Disponível em: ⟨https://doi.org/10.64898/2026.04.21.26351421⟩.

TOMASELLI, G. F.; ZIPES, D. P. What causes sudden death in heart failure? *Circulation Research*, v. 95, n. 8, p. 754–763, 2004.

VASWANI, A. et al. Attention is all you need. In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. [S.l.: s.n.], 2017. v. 30, p. 5998–6008.

ZEPPENFELD, K. et al. 2022 ESC guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death. *European Heart Journal*, v. 43, n. 40, p. 3997–4126, 2022.